

CAPÍTULO 13.53

Cáncer de Faringe y Laringe

PERFIL EUNACOM 1.13.53

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los cánceres de la vía aerodigestiva superior, específicamente el **cáncer de faringe** y el **cáncer de laringe**, comparten una característica clínica fundamental: suelen ser **asintomáticos** en sus estadios iniciales. Cuando los síntomas se hacen evidentes, habitualmente la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada.

Cáncer de Faringe

La presentación clínica del cáncer de faringe varía significativamente según la zona anatómica afectada: rinofaringe (nasofaringe), orofaringe o hipofaringe.

1. Rinofaringe (Nasofaringe)

Es una zona de difícil acceso clínico, por lo que suele debutar de forma silente o inespecífica.

- **Adenopatía cervical:** Es la forma de manifestación **más frecuente**. Aunque es inespecífica (cualquier cáncer de cabeza y cuello puede darla), ante una masa cervical en un adulto sin foco infeccioso, debe sospecharse.
- **Síntomas Otológicos:** El tumor puede obstruir la trompa de Eustaquio.
 - **Otitis Media con Efusión (OME)** en el adulto (especialmente si es unilateral).
 - Otitis media crónica.
- **Síntomas Nasales:** Obstrucción nasal por compromiso de las coanas.
- **Otalgia:** Dolor referido al oído (otalgia secundaria).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Ojo en el EUNACOM! Una otitis media con efusión (presencia de líquido en el oído medio) en un paciente **adulto** es un signo de alarma que obliga a descartar un tumor en la rinofaringe que esté obstruyendo la trompa de Eustaquio.

2. Orofaringe e Hipofaringe

Estas localizaciones comparten síntomas debido a su cercanía mecánica durante la deglución.

- **Odinofagia:** Dolor al tragar.
- **Disfagia:** Dificultad para tragar, generalmente progresiva.
- **Otalgia referida:** El dolor faríngeo se irradia frecuentemente al oído.
- **Cambios en la voz (Hipofaringe):** Debido a su relación anatómica con la laringe, puede presentarse como **disfonía** o cambios en la resonancia (timbre) de la voz.

TABLA 13.53.1: LOCALIZACIÓN VS SÍNTOMA PRINCIPAL / INICIAL

LOCALIZACIÓN	SÍNTOMA PRINCIPAL / INICIAL	OTROS SÍNTOMAS
Rinofaringe	Adenopatía cervical	OME unilateral, obstrucción nasal, otalgia.
Orofaringe	Odinofagia / Disfagia	Otalgia referida.
Hipofaringe	Odinofagia / Disfagia	Cambios en la resonancia de la voz, disfonía.

Cáncer de Laringe

La clínica y el pronóstico del cáncer de laringe dependen estrictamente de su ubicación con respecto a las cuerdas vocales.

Clasificación Anatómica y Clínica

- **Supraglótico (por encima de las cuerdas vocales):**
 - Presenta un **mal pronóstico** relativo porque da síntomas tardíos.
 - Síntomas iniciales: Prurito laríngeo (sensación de picazón o cuerpo extraño).

- Síntomas tardíos: Disnea obstructiva y disfonía por invasión hacia abajo.
- **Glótico (en las cuerdas vocales):**
 - Es el de **mejor pronóstico**.
 - Síntoma precoz: **Disfonía** (voz rasposa o "leñosa").
 - Al dar síntomas tempranamente, el diagnóstico suele ser en etapas iniciales.
- **Infraglótico (por debajo de las cuerdas vocales):**
 - Se manifiesta principalmente con **disnea** (obstrucción de la vía aérea inferior) y disfonía.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Pronóstico: El cáncer glótico tiene mejor pronóstico por dos razones: 1. **Clínica precoz:** La mínima irregularidad en la cuerda vocal genera disfonía inmediata. 2. **Drenaje linfático:** La región glótica es muy pobre en vasos linfáticos, lo que retrasa la diseminación hacia los ganglios del cuello. Por el contrario, las zonas supra e infraglóticas tienen una red linfática muy rica, favoreciendo metástasis precoces.

Diagnóstico

Ante cualquier sospecha de patología tumoral en la vía aerodigestiva, el estudio debe ser sistemático.

- **Examen de elección: Nasofibrolaringoscopia (NFL).** Es un examen endoscópico flexible que permite visualizar desde la rinofaringe hasta la laringe.
- **Confirmación: Biopsia** de la lesión sospechosa observada en la NFL.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Toda **Disfonía** que dure **más de 3 semanas** en un paciente con factores de riesgo (tabaco, alcohol) debe ser evaluada obligatoriamente con una **Nasofibrolaringoscopia** para descartar malignidad.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento es multidisciplinario y depende de la extensión (estadaje) y localización del tumor.

Opciones Terapéuticas

- **Cirugía:** - **Laringectomía total:** Implica la extirpación completa de la laringe. Requiere la realización de una **traqueostomía** definitiva (el paciente pierde la conexión natural entre vía aérea superior y pulmones). - **Laringectomía parcial / Microcirugía:** Se intenta en tumores pequeños o localizados para preservar la función fonatoria (la voz). - **Radioterapia y Quimioterapia:** Se utilizan como tratamiento adyuvante, neoadyuvante o como tratamiento único en casos específicos.

Consideraciones Especiales

- **Cáncer Glótico Localizado:** En tumores pequeños confinados a la cuerda vocal, se puede optar por **radioterapia sola** o **microcirugía láser**, logrando excelentes tasas de curación y preservando la voz del paciente. - **Rehabilitación:** En pacientes con laringectomía total, la pérdida de la voz es el impacto más severo, requiriendo rehabilitación con fonoaudiología, prótesis fonatorias o laringófonos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La causa más frecuente de **otalgia** (dolor de oído) con un examen físico del oído (otoscopía) normal, es el dolor referido. Siempre se debe examinar la faringe, la laringe, el cuello y la articulación temporomandibular (ATM) en busca de la causa primaria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 62 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disfonía progresiva de 2 meses de evolución. Describe su voz como rasposa. No presenta disnea, disfagia ni baja de peso. ¿Cuál es el estudio inicial más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Faringe y Laringe. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cáncer de faringe: generalmente asintomático en estadios iniciales → diagnóstico tardío.
- Rinofaringe: adenopatía cervical (más frecuente pero inespecífica), otitis media con efusión/crónica (obstrucción trompa de Eustaquio), obstrucción nasal.
- Otolgia: común a TODO el cáncer de faringe. La causa más frecuente de otalgia en general es dolor REFERIDO, no del oído mismo.
- Orofaringe e hipofaringe: odinofagia y disfagia predominantes. Hipofaringe además puede dar disfonía/cambio de resonancia vocal.
- Cáncer supraglótico: síntomas tardíos (prurito laríngeo → disnea → disfonía) → MAL pronóstico.
- Cáncer glótico: disfonía PRECOZ (voz rasposa/leñosa) + pobre irrigación linfática → MEJOR pronóstico.
- El glótico tiene mejor pronóstico por 2 razones: da síntomas antes y se disemina más lento (poca irrigación linfática).
- Cáncer infraglótico: disnea + disfonía, irrigación linfática rica → peor pronóstico que glótico.
- Estudio de elección: nasofibro-laringoscopia. Toda disfonía ≥3 semanas debe estudiarse con este examen.
- Tratamiento cáncer de laringe: laringectomía + traqueostomía + quimio/radio. Excepción: glótico localizado → radio o microcirugía (preservar voz).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE FARINGE Y LARINGE)**PREGUNTA 1**

Hombre de 62 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disfonía progresiva de 2 meses de evolución. Describe su voz como rasposa. No presenta disnea, disfagia ni baja de peso. ¿Cuál es el estudio inicial más adecuado?

- A) Radiografía de tórax
- B) TAC de cuello con contraste
- C) Nasofibro-laringoscopia
- D) Ecografía de cuello
- E) RMN de cuello

PREGUNTA 2

Paciente de 55 años consulta por otalgia derecha persistente de 6 semanas. La otoscopia es normal. Además refiere obstrucción nasal derecha y en el examen se palpa una adenopatía cervical derecha dura. ¿Cuál es la localización más probable del cáncer primario?

- A) Laringe (glótico)
- B) Rinofaringe
- C) Orofaringe
- D) Esófago cervical
- E) Laringe (supraglótico)

PREGUNTA 3

Respecto al pronóstico del cáncer de laringe según su localización, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El cáncer supraglótico tiene el mejor pronóstico porque se detecta tempranamente
- B) El cáncer glótico tiene mejor pronóstico porque da síntomas precoces y tiene pobre irrigación linfática
- C) El cáncer infraglótico tiene el mejor pronóstico por su accesibilidad quirúrgica
- D) Todos los cánceres de laringe tienen el mismo pronóstico independientemente de la localización
- E) El cáncer glótico localizado siempre requiere laringectomía total

RESUMEN: CÁNCER DE FARINGE Y LARINGE

El cáncer de faringe es habitualmente asintomático en estadios iniciales, lo que lleva a diagnósticos tardíos. La clínica varía según la localización. El cáncer de rinofaringe se manifiesta más frecuentemente con una adenopatía cervical (forma más frecuente pero inespecífica); los síntomas más clásicos incluyen otitis media con efusión u otitis media crónica (por obstrucción de la trompa de Eustaquio) y obstrucción nasal (por obstrucción de la coana). La otalgia es común a todo el cáncer de faringe, ya que el dolor faríngeo se refiere frecuentemente al oído (de hecho, la causa más frecuente de otalgia en general no son problemas del oído sino dolor referido). Los cánceres de orofaringe e hipofaringe producen más odinofagia y disfagia. El cáncer de hipofaringe puede producir además cambios en la voz (disfonía o cambio en la resonancia vocal) por su relación anatómica con la laringe. El cáncer de laringe se subdivide según localización en supraglótico, glótico e infraglótico. El supraglótico da síntomas tardíos (prurito laríngeo inicial, luego disnea y disfonía), tiene mal pronóstico. El glótico produce disfonía precoz (voz rasposa/leñosa) y tiene mejor pronóstico por dos razones: síntomas tempranos y pobre irrigación linfática que retrasa la diseminación. El infraglótico produce disnea y disfonía. El estudio de elección para el cáncer de laringe y la disfonía crónica (>3 semanas) es la nasofibro-laringoscopia. El tratamiento general es laringectomía + traqueostomía + quimio/radioterapia, pero en cáncer glótico localizado se puede hacer radioterapia o microcirugía sola para preservar la voz.